

I 抗悪性腫瘍薬 anticancer drugs

到達目標

- 抗悪性腫瘍薬について、全身状態の評価に基づいた適応が判断できる
- それぞれの抗悪性腫瘍薬の薬理作用と有害事象を説明できる
- それぞれの抗悪性腫瘍薬の適切な投与方法と有害事象が起きたときの対処法を説明できる

1 癌薬物療法の基本

一般的に胸部腫瘍領域に用いられる癌薬物治療は、細胞傷害性抗癌薬、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬に分類される。それぞれエビデンスを基にした適応の有無や、薬理学を十分に理解しながら用いる必要がある。抗悪性腫瘍薬投与の適応としては、①有効性が期待できる、②薬物療法に耐えうる全身状態であり、各種臓器が健常である、③患者本人が薬物療法を受ける意思を有している、などが挙げられる。

①有効性が期待できる

有効性に関しては、主に第3相臨床試験によって得られた生存期間や無増悪生存期間の延長を示した標準治療を第一に選択肢として検討する。近年は希少がんや特定の遺伝子変異陽性集団であるいわゆる希少フラクションに対して第2相試験の有効性をもとに保険適用が得られる事例も増えている。

②薬物療法に耐えうる全身状態であり、各種臓器が健常である

全身状態の評価としては、Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) の提唱している performance status (PS) が用いられる (表1)。また臓器特異的な毒性を有する抗悪性腫瘍薬についてはその当該臓器に障害がないか注意を要する。細胞傷害性抗癌薬の使用にあたっては腎機能、肝機能の評価は必須であるし、シスプラチンのように大量の補液を必要とする際は心機能の評価も必要となる。また、間質性肺疾患の合併した患者では治療適応の有無や治療選択に対して慎重を要する。近年標準治療として幅広く使用さ

れるようになった免疫チェックポイント阻害薬の使用にあたっては自己免疫疾患の合併、既往も重要な情報である。

③患者本人が薬物療法を受ける意思を有している

当然のことながら患者本人の薬物療法を受ける意思は重要である。従来のインフォームドコンセントでは、医師が患者に対して治療法やリスクについて十分な情報を提供し、患者の同意を得ることを目的とし、医師が治療法を提案し、患者はその提案に「同意するか拒否するか」を決める立場にあった。

近年では Shared Decision Making (SDM: 共有意思決定) の考え方が重要視されている。

がん治療における SDM は医療従事者と患者が協力し合い、患者の価値観や希望を尊重しながら最適な治療方針を共に選択するプロセスである。患者自身が自らの治療について理解し、積極的に意思決定に関与することが求められるようになってきた。SDM の基本的な考え方として、まず患者が自身の価値観や人生の目標に基づいて意思決定を行えるよう、医療従事者は十分な情報を提供し、患者が理解しやすい言葉で説明することが求められる。

2 細胞傷害性抗癌薬 (表2)

a プラチナ製剤

i) cisplatin (CDDP)

プラチナ化合物である cisplatin (CDDP) は肺癌治療におけるキードラッグのひとつであり、非小細胞肺癌、小細胞肺癌ともに初回治療、術後補助化学療法、化学放射線療法にて用いられる。作用機序としては構造中の塩素が水と置換され、荷電状態となり、DNA 中で2本鎖間に架橋を形成し作用する。

ii) carboplatin (CBDCA)

CDDP の誘導体であり、CDDP で問題となる消化器症状や腎毒性を軽減するために開発されたプラチナ製剤である。CDDP で必要となる輸液負荷が不要となるため、外来で用いることも容易である。carbo-

表1 ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) Performance Status

PS	全身状態
0	無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる。
1	軽度の症状があり、肉体的労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる (たとえば軽い家事、事務など)。
2	歩行や身の回りのことはできるが、ときに少し介助が必要なこともある。軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している。
3	身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している。
4	身の回りのこともできず、常に介助が必要で、終日就床を必要としている。